



Nomor : 8002/VII-05/0925

Malang, 23 September 2025

Hal : Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Sectio Caesaria

Yth. Direktur/Kepala FKRTL Mitra BPJS Kesehatan Cabang Malang
di
Malang Raya

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis Sectio Caesaria yang telah dilaksanakan oleh TKMKB Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Agustus 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Audit Medis Sectio Caesaria:

a. Temuan medis

1) Prosedur SC dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas, seperti:

- Kasus KPD tanpa ada upaya persalinan pervaginam /induksi.
- Belum memenuhi kriteria induksi gagal, seperti: tidak mencantumkan indikasi gagal maternal maupun fetal, belum mencapai 2 kolf sudah dikatakan gagal. BSC 1x tanpa ada indikasi lainnya
- Oligohydramnion tidak ada keterangan AFI pada hasil foto USG (AFI <4 absolut SC, jika AFI <8 harus ada penyebab lain yang mendukung)
- Lilitan tali pusat tanpa upaya partus percobaan
- Prolonged kala 1 fase laten (pembukaan <3) seharusnya ditunggu/ dipulangkan dulu
- Prolonged kala 1 fase aktif tanpa upaya induksi akselerasi dan tidak didapatkan keterangan kelainan presentasi (letak puncak).
- CPD(disproporsi) tanpa ada keterangan ukuran panggul dalam (baik saat ANC/MRS)
- Myopia dengan spheris -7 tidak ada hasil pemeriksaan spesialis mata dengan keterangan kelainan/degenerasi retina
- Terminasi kehamilan karena PEB (tidak ada kontraindikasi persalinan pervaginam) tanpa ada upaya induksi

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. R. Tumenggung Suryo 44 Malang

Telp. +62 341 493026

Fax. +62 341 493802

www.bpjs-kesehatan.go.id

- Primi tua/ HSVB bukan merupakan indikasi absolut SC
 - Bayi besar namun tidak ada data yang mendukung (TFU >40 cm, BB bayi saat lahir >3800gr, TBJ dari USG)
 - Fetal distress dengan hasil NST normal dan tidak ada tatalaksana rehidrasi O² miring kiri.
- 2) Pemberian induksi pada pasien dengan kontraindikasi (dilakukan induksi pada pasien BSC, CPD).
 - 3) Ditemukan adanya kesalahan dalam interpretasi hasil NST.
 - 4) Ditemukan diagnosis PEB yang tidak memenuhi kriteria diagnosis PEB.
- b. Temuan administratif
- 1) Ditemukan inkonsistensi penulisan rekam medis
 - Terdapat penambahan diagnosis dengan bentuk tulisan yang berbeda
 - Variasi bentuk tanda tangan DPJP
 - Data di resume medis tidak tertulis dengan lengkap (sesuai dengan rekam medis) untuk menunjang diagnosis akhir pasien, baik pada anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang
 - Data penunjang suatu diagnosis tidak lengkap (bayi besar, tidak ada informasi di rekam medis untuk menunjang diagnosis bayi besar)
 - Terdapat inkonsistensi pencatatan pada lembar triase, lembar CPPT dan lembar assesmen rawat inap DPJP
 - Terdapat coretan penulisan tekanan darah pada lembar assesment rawat inap DPJP dan CPPT
 - Terdapat kasus pada lembar CPPT tercatat VT pembukaan 1, sedangkan pada resume tercatat tidak ada pembukaan.
 - 2) Ditemukan lembar partograf yang tidak diisi.
 - 3) Tidak dituliskan hasil bacaan USG.
 - 4) Tidak dituliskan kondisi bayi baru lahir di laporan operasi (berat bayi, jenis kelamin dll).
 - 5) Terdapat potensi rujukan berasal dari bidan praktek tertentu, tanpa indikasi medis yang jelas.
 - 6) Ditemukan asal masuk pasien tidak jelas (bukan poli/ UGD) melainkan "Pasien Datang Sendiri" dengan indikasi SC tidak jelas.
 - 7) Beberapa Protap terkait tindakan obstetri misalnya Protap induksi kehamilan belum ada

2. Rekomendasi TKMKB terkait Audit Medis Sectio Caesaria:

a. Untuk Manajemen RS:

- 1) Revisi PPK kasus sectio caesaria untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman/guideline agar disusun kembali sesuai acuan terbaik, dan dikomunikasikan dengan Perhimpunan Profesi terkait.
- 2) Melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran tenaga medis maupun paramedis dalam hal ketertiban dalam penulisan rekam medis pasien.
- 3) Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan RS yang dapat berperan secara maksimal dan berintegritas dalam mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian.

b. Untuk DPJP:

- 1) Melakukan prosedur SC sesuai indikasi yang benar berdasarkan pedoman klinis yang berlaku dan acuan terkini yang direkomendasikan.
- 2) Menuliskan rekam medis maupun resume medis secara lengkap dan baik.

c. Untuk Dokter Umum dan Bidan:

- 1) Di IGD, dokter umum dan bidan harus memahami kriteria gawat darurat kebidanan.
- 2) Di ruangan, bidan harus memahami kriteria gawat darurat maternal dan gawat darurat janin dan memahami proses persalinan sesuai dengan APN (asuhan persalinan normal).
- 3) Bidan wajib tertib dalam menuliskan pemantauan partograf

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pps Kepala

Ariyanti

Tembusan: Ketua TKMKB Cabang Malang.

AN/de/pk00